

Fecha Última Actualización: 11-03-2023 18:02:45

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Christian Mario Consuegra Prieto
Edad : 55a 4m 14d
Dirección : Padre Hurtado 1222 P Alto

Rut : 10.792.857-K
Fecha Nacto: 25/10/1967
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A583067
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9761 1061

N° Epicrisis
344991

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 13/01/2023 19:40

Días Estadía: 57

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 11/03/2023 18:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES PATOLOGICOS:

- Insuficiencia cardíaca FEVI reducida (EcoTT 08/22: FEVI 31%)
- Cardiopatía coronaria (04/22: PCI ADA, 09/22: 3 DES a ADA media, proximal e intermedia)
- HTA
- DM2 IR
- Monorreno derecho (nefrectomía izquierda por carcinoma renal de células claras). ERC en HD por catéter tunelizado (retirado)

Quirúrgicos: Resección de nevo dérmico, instalación de catéter hemodiálisis tunelizado yugular derecho 04/07/22, nefrectomía radical izquierda. Cirugía por várices

Hospitalizaciones recientes:

- 19/12/22-04/01/23: CHD disfuncional, se cambia tunelizado por Seldinger. Anemia moderada de enfermedades crónicas. Derrame pleural bilateral obs 2rio a ICC/ERC
- 25-28/07: CHD disfuncional, se cambia tunelizado por Seldinger
- 14/09: Angioplastia electiva con DES en tercio medio proximal de ADA, 1 DES en tercio proximal medio de ramo diagonal mayor, 1 DES en ramo intermedio, sin incidentes
- 09/07-13/07: Sangrado en relación a sitio de inserción de CHD
- 29/06-06/07: Disfunción CHD, se instaló nuevo CHD tunelizado YD
- 16/04-06/05: SDRA severo x COVID-19 + IAM sin SDST.

SOCIAL: Chófer, vive con su madre. Refiere leve dependencia para las actividades instrumentales, en contexto de disnea

MEDICACION HABITUAL:

- Enalapril 5 mg/día
- Espironolactona 12.5 mg/día
- Furosemida 40 mg c/12 hrs
- Carvedilol 25 mg c/12 hrs
- Aspirina 100 mg/día
- Clopidogrel 75 mg/día

Fecha Epicrisis : 11/03/2023 18:02

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 11-03-2023 18:02:45

Página 2 de 4

-Atorvastatina 40 mg/día

-Ácido fólico 5 mg/día, Carbonato de calcio 500 mg c/12 hrs (con las comidas), Omeprazol 20 mg/día, Alopurinol 100 mg/día, Bicarbonato de sodio 1 g c/8 hrs, Lorazepam 2mg/noche

ALERGIAS: (-)

HÁBITOS: TBQ (+) IPA 20, OH (+), Drogas (+) THC diario

ENFERMEDAD ACTUAL:

Derivado desde APS el 13/02 por cuadro de 48 hrs de evolución caracterizado por fiebre hasta 38.5°C, CEG, disnea y tos. Ingres a FC 86 lpm, PA 140/86 mmHg, PAM 104, T 36°, FR 30 rpm, sat 96% con O2 3 L/min: al examen físico se describe MP (+) abolido en hemicampo derecho, crépitos a izquierda, edema de EEII.

LABORATORIO DE INGRESO: Hb 7.4 VCM 85 GB 8380 Plaq 203000 PCR 165 Glucosa 316 troponina 67.9 BUN 90 ELP 133/4.7/93 pH 7.38 CO2 40.3 HCO3 23.7 Ca 8.8 Mg 1.3 INR 1.48 TTPA 45.5 PCR SARS-COV-2 (-) VIH (-), VHB (-), VHC (-)

TAC tórax 13/01: Neumopatía centrada en LSI, podría ser de origen inflamatorio infeccioso. Moderado derrame pleural bilateral, loculado, no caracterizable.

Ingres a UTIM

Diagnósticos:

- 1.ITS/CVC por SAMS
- 2.Insuficiencia respiratoria aguda en resolución
- 2.1.Empiema pleural derecho por SAMS
- 2.2.Neumonía LSI
- 2.3.Atelectasias bibasales
- 3.Hematoma iatrogénico post instalación de CHD
- 4.Anemia severa
- 5.Crisis convulsiva reactiva

EVOLUCION UTIM

HDN/CV: estable, presentó caída de Hb tras instalación de CVC transitorio para HD femoral derecho, con necesidad de múltiples transfusiones de GR. Angiotac x 2: Pequeño foco de sangrado activo en músculo sartorio izquierdo en relación al transcurso trans muscular de catéter venoso femoral ipsilateral asociado a engrosamiento difuso con densidad hemática de los tercios medio y proximal del músculo sartorio sin identificar una colección hemática claramente definida en su espesor susceptible de punción. Extensa enfermedad ateromatosa mixta difusa aortoiliaca y de EEII. Evaluado en múltiples oportunidades por cirugía vascular y de turno, sin indicación quirúrgica.

Posteriormente se mantuvo estable con Hb > 7, sin embargo, en relación a instalación de pleurostomía (03/02) y fibrinólisis (06/02), presentó abundante débito hemático y coágulos por el drenaje pleural, caída de Hb de 7.3 a 5.2, e hipotensión, se transfundió en total 5 U a la fecha. Hoy Hb en 6.5, tiene indicada 2 UGR (de las cuales ha pasado 1) y se reservan 2 UGR para pabellón. Desde hoy requiriendo NAD en dosis bajas de manera intermitente.

RESPIRATORIO: Estudio de líquido pleural compatible con empiema derecho por SAMS, se instaló pleurostomía derecha el 18/01, con disminución de la cuantía del derrame, se intentó fibrinólisis el 01/02, que resultó frustra por tubo desplazado al subcutáneo, por lo que se retiró el 02/02. Se instaló nueva pleurostomía el 03/02, la que queda aspirativa. El 06/02 se realiza fibrinólisis con alteplase posterior a lo cual presentó 2120 cc de débito hemático con caída de Hb que requirió transfusión de GR. Rx tórax con aumento del derrame pleural derecho comparado con imágenes previas. Evaluado por Cx tórax, dado evento reciente se decide suspender 2da fibrinólisis. Se solicita Angiotac de tórax que no evidenció sangrado activo pero si pleurostomía desplazada, el 08/02 se reposiciona pleurostomía. Rx tórax de control evidencia aumento empiema, por lo que finalmente se decide explorar en pabellón hoy. Desde su ingreso con requerimientos de O2 por naricera hasta hoy AM que aumenta de forma abrupta requerimientos de O2 hasta CNAF 50/50.

INFECCIOSO: bacteremia por SAMS + empiema derecho por mismo agente, por temporalidad no se pudo determinar si

Fecha Epicrisis : 11/03/2023 18:02

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 11-03-2023 18:02:45

Página 3 de 4

correspondió a ITS ¿ CVC, de todos modos, catéter tunelizado retirado y con drenaje pleural que mantiene. HC negativos del 21/01, con resto de estudio de diseminación negativo (fondo de ojo, TAC TAP sin abscesos, ecoTT sin vegetaciones). En tratamiento con cefazolina.

GASTROINTESTINAL: dolor abdominal en HD con abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal. Impresiona en relación a contigüidad con empiema, de todos modos se realizó AngioTC AP que descartó complicaciones a nivel gastrointestinal.

RENAL/MEDIO INTERNO: ERC en HD trisemanal, anúrico. Acceso retirado dado bacteremia y colonización versus ITS CVC por SAMS. Actualmente > 14 días de tratamiento antibiótico desde HC negativos, de momento en diálisis por catéter femoral izquierdo transitorio, pendiente instalación de nuevo catéter tunelizado. Última HD el 07/02/23 sin conflicto, ayer HD solo por 45 min, suspendida por dolor abdominal. HD programada hoy por nephrocare, SE DEBE LLAMAR AL VOLVER DE PABELLÓN, si paciente estable HD según programación por nefrología, si inestable diferir HD hasta mañana con nueva evaluación por nefrología.

NEURO: Presentó 4 episodios de CTCG con AngioTAC de cerebro sin lesiones y sin alteración metabólica que lo expliquen. EEG muestra solamente lentitud intermitente generalizada. Evaluado por neurología, se interpreta como crisis reactiva. De momento está recibiendo levetiracetam, a evaluar indicación de mantención pre alta.

TROMBOPROFILAXIS: HNF suspendida por sangrado post fibrinólisis del 06/02.

Paciente ingresa a UPC Post Pabellón:

Según consta en protocolo quirúrgico: se explora cavidad pleural identificando abundante líquido hemático [3400 ML], se envía líquido a cultivo Drenaje pleural #24 fr a la base, se fija con seda 2.0. Drenaje pleural #24 al apice, se fija a la piel con seda 2.0 agrafes a la piel. Se conectan drenajes a aquaseal, quedando aspirativas a -15cmH2O.

Segundo tiempo. se instala pleurostomía izquierda número 24fr, dando salida a líquido serohemático se envía muestra a cultivo corriente, hongo y koch. aspirativo a -15cmH2O

Paciente ingresa con SAS 1 , pupilas isoreactivas, requerimiento de NAD 0.10mcg/kg/min, Llame capilar 3 seg , MP+ hipoventilación a predominio derecho, TOT 22cm en comisura, Abdomen blando depresible rha+.
Recibiendo GR (4ta) unidad del día.

Evolución en UCI.

Estuvo 29 días en la unidad.

Inicialmente con evolución, lenta pero favorable, de empiema pleural.

Logra extubarse en su 2da semana de estadía.

Sin embargo cursa con estatus epiléptico refractario multifactorial lo que motiva a re-intubarlo. Estatus epiléptico de difícil control, hasta con 4 fármacos anticonvulsivantes.

En forma paralela desarrolló NAVM 2ario a PSAE que ganó resistencia a carbapenémicos, además de Citrobacter, Serratia y Stafilococo MR de origen.

Tuvo evento de Shock Hemorrágico en contexto de hemo-neumotórax incidental por paciente con agotamiento vascular. En ese contexto tuvo 2 eventos de PCR en el intento de embolizar lesión vascular en ápice pulmonar con apoyo de radiología intervencional. Se mantuvo trombocitopénico severo en forma intermitente como causa asociada. Logró estabilizarse con manejo médico con transfusiones y manejo de coagulopatía asociada. Cabe destacar que Mantuvo terapia dialítica programada.

Evolucionó con encefalopatía post-PCR lo que dificultó la salida al ventilador asociado a mala respuesta infectológica a terapia antibiótica de amplio espectro.

Evolucionó últimas 24 horas, con progresión de Shock y FOM.

Se constata fallecimiento a las 17:35, en compañía de sus familiares.

Diagnóstico de Egreso

Shock séptico - NAVM

Paro cardiorespiratorio recuperado -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fecha Epicrisis : 11/03/2023 18:02

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:59

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fallecido

Plan Post Alta

Fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Daniel Sánchez Sobarzo
Médico Tratante (Staff)